

Tabelle 16: Kriterien zur Auswahl der prognoseverbessernden Substanzklassen bei HFref

Substanz- klasse	getestet gegen/ im Vergleich zu	Mortalität, Hospitalisie- rungen	langfristige renale Endpunkte ^a	Hypo- tonie- risiko	Diuretika- gebrauch	weitere Anwendungsgebiete unter Berücksichtigung der NVL KHK, NVL Diabetes und NVL Hypertonie	wichtige Kontraindikationen und Sicherheitshinweise
RASi	ACEi auf Basis von Digitalis u. a.	↓	(↔) ^b	↑	(↔)	- arterielle Hypertonie - nach Myokardinfarkt - chronische Nierenerkrankungen, insb. diabetische Nephropathie^b	- Hypotonie - Hyperkaliämie - Angioödem - Husten^c
	ARB Placebo	↓	(↔) ^b	↑	(↔)		
	ACEi ACEi	↔	(↔)	↔	(↔)		
ARNi	ACEi/ARB auf Basis von BB (+MRA), nach Vortherapie mit ACEi/ARB	↓	(↓)	↑	↓		- Vorsicht bei eGFR < 30 ml/min/1,73 m² - Hypotonie (nicht beginnen bei SBP < 100 mmHg) - Hyperkaliämie (nicht beginnen bei K > 5,4 mmol/l) - Angioödem
	BB ^d Placebo auf Basis von ACEi/ARB (+Digitalis)	↓	(↔)	↑	(↔)	- nach Myokardinfarkt A. pectoris - Tachyarrhythmien	- Bradykardie - AV-Block - Hypotonie (kontraindiziert bei SBP < 90 mmHg)
MRA ^{e,f}	Placebo auf Basis von RASi+BB	↓	?	↑	↓	- therapieresistente Hypertonie^e - nephrotisches Syndrom^e - primärer Hyperaldosteronismus^e - Ausgleich des kaliuretischen Ef- fekts von Diuretika^g	- kontraindiziert bei eGFR < 30 ml/min/1,73 m² und/oder Serum-Kreatinin > 1,8 mg/dl - Hyperkaliämie, Hyponatriämie - Hypotonie^e - Gynäkomastie^e - gastrointestinale Nebenwirkungen^f
SGLT2i ^{h,i}	Placebo auf Basis von RASi+BB (+MRA)	↓	↓	↔	↓	- Typ 2-Diabetes - chronische Nierenerkrankungen	- nicht beginnen bei eGFR < 25/20 ml/min/1,73 m² - urogenitale Infektionen - atypische Ketoazidose (Risiko erhöht bei Diabe- tes mellitus und akuten Erkrankungen)

Die Tabelle enthält eine **stark vereinfachte Darstellung** der Evidenz sowie der von der Leitliniengruppe getroffenen Auswahl von Anwendungsgebieten, Kontraindikationen und Nebenwirkungen der bei Herzinsuffizienz relevanten Wirkstoffe. Für die ausführliche Beschreibung der Evidenz mit Effektmäßen und Aussagesicherheit siehe Hintergrundtexte und Evidenztabellen; für die vollständige Darstellung der Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen siehe Fachinformationen der einzelnen Wirkstoffe sowie Empfehlungen der NVL. Typ-2-Diabetes [147], NVH Chronische KHK [148] und NVL Hypertonie [149]. CAVE: Für einige Wirkstoffe der aufgeführten Substanzklassen liegt keine Zulassung für die Behandlung von Herzinsuffizienz vor bzw. nicht für alle klinischen Settings im Rahmen der Behandlung von Herzinsuffizienz (Off-Label-Use).

Legende: ↓ Endpunkt seltener erreicht; ↑ Endpunkt häufiger erreicht; ↔ neutrale Effekt; ? keine ausreichende Evidenz aus Herzinsuffizienz-Studien; () Angaben in Klammern: aus Studien zu Herzinsuffizienz keine bzw. methodisch schwache Evidenz aus Subgruppenanalysen.

Anmerkungen: ^a RASi, MRA und SGLT2i können kurzfristig einen hämodynamisch bedingten Kreatininanstieg auslösen, der in der Regel aber keine strukturelle Nephrotoxizität reflektiert. ^b in Studien zu Herzinsuffizienz keine Effekte, jedoch in Studien zu chronischen Nierenerkrankungen Reduktion renaler Endpunkte; ^c nur ACEi; ^d Bisoprolol, Carvedilol, Metoprolol, Nebivolol; ^e Spironolacton; CAVE: keine ausdrückliche Zulassung für Herzinsuffizienz; ^f Eplerenon; ^g klinisch relevanter Aspekt, keine Zulassung; ^h Dapagliflozin; ⁱ Empagliflozin

Abkürzungen: ACEi Angiotensin Converting Enzyme-Inhibitoren; ARB Angiotensinrezeptorblocker; ARNI Angiotensin-Rezeptor-Nephtylisin-Inhibitoren; BB Betarezeptorenblocker; eGFR geschätzte glomeruläre Filtrationsrate; MRA Mineralokor-
tikoidrezeptorantagonisten; RASi Renin-Angiotensin-System-Inhibitoren; SGLT2i Sodium dependent glucose co-transporter 2 Inhibitoren; K Kalium; SBP systolischer Blutdruck